

Radar de sinais relevantes para a realidade hospitalar nacional

Portugal 04/2026

Versão nº 1 de 11-05-2026

Relatório produzido pela PDH
para a produção de informação relevante na área da
farmacovigilância.



RESUMO

A análise integrada da realidade nacional de abril de 2026, cruzada com os sinais de segurança regulamentares do mesmo período, identificou quatro áreas de relevância para a prática clínica e para a interpretação das notificações de reações adversas a medicamentos (RAM).

Do ponto de vista regulamentar, o PRAC, na reunião de 7–10 de abril de 2026, aprovou uma Comunicação Direta a Profissionais de Saúde (DHPC) para o medicamento cenobamato (Ontozry) por associação a lesão hepática grave, que pode ter impacto nos serviços onde há prescrição de antiepiléticos. A nível nacional, o Infarmed emitiu um alerta com repercussão hospitalar: a suspensão de exportação de 28 medicamentos, incluindo fármacos oncológicos e de doenças crónicas.

SINAL A – CENOBAMATO (ONTOZRY) E LESÃO HEPÁTICA GRAVE

Fonte: PRAC 7–10 de abril de 2026 – Comunicação Direta a Profissionais de Saúde (DHPC)

EMA – Meeting highlights PRAC 7–10 April 2026: ema.europa.eu

O PRAC aprovou a elaboração de uma comunicação direta aos profissionais de saúde (DHPC) para informar que foram notificados casos de lesão hepática grave com insuficiência hepática em doentes tratados com o medicamento Ontozry. A maioria dos casos ocorreu quando o medicamento foi utilizado em associação com outros medicamentos anticonvulsivantes.

O PRAC recomendou a adição de lesão hepática grave como efeito adverso raro ($\leq 1/1.000$) na informação do medicamento, com aviso explícito para profissionais e doentes. Adicionalmente, é recomendada a monitorização da função hepática antes do início do tratamento e ao longo do mesmo.

O Ontozry é um medicamento que se encontra sob monitorização adicional, pelo que todas as reações adversas suspeitas devem ser notificadas, independentemente da gravidade das mesmas

O que importa rever nos casos locais

- Verificar se existe prescrição ativa de cenobamato na instituição e se os doentes são acompanhados com monitorização hepática periódica.
- Rever notificações de lesão hepática não explicada em doentes com epilepsia sob tratamento com mais do que um medicamento.
- Garantir que os profissionais que prescrevem antiepilépticos têm conhecimento da DHPC emitida.

Grau de prioridade local: Moderado

SINAL B - TIRZEPATIDA – RISCO DE INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA COM A VARFARINA E OUTROS DERIVADOS DA CUMARINA, LEVANDO A UMA DIMINUIÇÃO DA RAZÃO NORMALIZADA INTERNACIONAL (*INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO* - INR)

Fonte: European Medicines Agency (EMA). PRAC recommendations on signals adopted at the 7-10 April 2026 PRAC meeting [Internet]. Amsterdam: EMA; 2026 [cited 2026 May 8]. Available from https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-7-10-april-2026-prac-meeting_en.pdf

Este sinal refere-se a uma possível interação medicamentosa que pode levar à diminuição do INR (“international normalised ratio”), ou seja, uma redução do efeito anticoagulante esperado. Isto pode teoricamente aumentar o risco trombótico em doentes tratados com anticoagulantes cumarínicos.

O PRAC não concluiu ainda que exista uma relação causal confirmada, mas considerou haver dados suficientes para justificar monitorização e avaliação adicional. As recomendações foram:

- Para a tirzepatida, o titular da AIM deverá monitorizar este potencial risco nos próximos PSURs (Periodic Safety Update Reports).
- Para a warfarina e outros derivados cumarínicos:
 - a avaliação do risco relativo à warfarina deverá ser feita no próximo PSUR com submissão prevista até 1 de maio de 2033;
 - a avaliação do risco relativo ao acenocumarol deverá ser feita no próximo PSUR com submissão até 29 de setembro de 2027.

CONTEXTO REGULAMENTAR NACIONAL — ABRIL / MAIO 2026

Este mês registaram-se desenvolvimentos a nível regulamentar nacional com impacto direto na prática hospitalar e na gestão terapêutica.

Suspensão de Exportação de 28 Medicamentos

A circular 039/CD/100.20.200 de 13 de abril atualizou a lista de medicamentos com exportação temporariamente proibida por risco de escassez. A lista inclui fármacos utilizados no tratamento de cancro da bexiga, ovário e mama, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca aguda, condições psicóticas, esclerose múltipla e PHDA.

Em contexto hospitalar, é fundamental ativar protocolos de antecipação de ruturas nestas classes e articular com os Serviços Farmacêuticos estratégias de substituição terapêutica atempada.

Fonte: Público, Observador, JN, RTP — 15 abr 2026 | [Público, 15 abr 2026](#)

Pacote do Medicamento: Prescrição por DCI

O Governo eliminou a alínea c) das exceções à prescrição por substância ativa (continuidade de tratamento superior a 28 dias), aprovada em Conselho de Ministros a 9 de abril. Mantêm-se as exceções por margem terapêutica estreita e por reação adversa prévia documentada.

Para os prescritores hospitalares: casos que invocavam continuidade de tratamento para manter prescrição por marca terão de ser reavaliados. A notificação prévia de RAM poderá ser utilizada como fundamento clínico para a exceção remanescente.

Fonte: Público, 9 e 14 abr 2026 | [Público, 9 abr](#) | [Público, 14 abr](#)

Sensores de Glicose: Tensão Regulamentar

Em abril, o Infarmed emitiu circular a exigir prescrição de sensores de monitorização contínua de glicose por descrição genérica. A medida gerou oposição da Ordem dos Médicos e da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, sendo que a 6 de maio o Infarmed admitiu disponibilidade para rever a decisão.

Este tema é relevante para o quotidiano hospitalar no contexto de monitorização de doentes diabéticos internados, nomeadamente na compatibilidade dos sistemas com bombas de insulina existentes.

Fonte: Infarmed, abr 2026; Ordem dos Médicos; Público, mai 2026 | [infarmed.pt](#)

NOTA METODOLÓGICA

Este relatório resulta da análise integrada de duas fontes de informação:

- (1) recomendações de sinais de segurança do PRAC na reunião de 7-10 de abril de 2026;
- (2) notícias relevantes de âmbito regulamentar nacional e de imprensa especializada de abril e maio de 2026.

Relatório produzido pela PDH para a produção de informação relevante em farmacovigilância.